

TEMA 6.2 • INFECTOLOGÍA

Manejo de Contactos

PERFIL EUNACOM 1.05.1.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Manejo de Contactos en Enfermedades Infecciosas

Tipos de Contactos

- **Intradomiciliarios:** Personas que viven bajo el mismo techo. -
- Extradomiciliarios:** Personas que comparten mucho tiempo juntas (compañeros de trabajo, colegio, pasajeros de avión).

Tuberculosis (TBC)

- Estudiar al contacto de un caso bacilífero:
- Clínica (síntomas)
- Rx de Tórax
- Baciloscopia (a todos los contactos)
- **PPD** → solo en menores de 15 años y pacientes VIH

TABLA 6.2.1: RESULTADO VS MANEJO	
RESULTADO	MANEJO
Baciloscopia (+)	Tratar como caso con esquema de 4 fármacos (RHZE)
Menor de 15 años con Rx alterada (aunque BK -)	Tratar como caso
PPD > 10 mm (adulto)	Profilaxis con Isoniazida 6 meses
PPD > 5 mm (paciente VIH)	Profilaxis con Isoniazida 9 meses
Menor de 15 años (independiente del PPD)	Isoniazida siempre: 3 meses → Repetir PPD; si vira → completar 6 meses
RN hijo de madre TBC	Isoniazida profiláctica. BCG después de terminar la profilaxis. Sí a lactancia materna .

Hepatitis

TABLA 6.2.2: TIPO VS CONTACTO INTRADOMICILIARIO		
TIPO	CONTACTO INTRADOMICILIARIO	CONTACTO EXTRADOMICILIARIO
Hepatitis A	Inmunoglobulina específica (o genérica si no hay)	Vacunación
Hepatitis B	Vacunación o Inmunoglobulina específica anti-HBs	Vacunación

- RN hijo de madre HBsAg (+): **Vacuna + Inmunoglobulina específica anti-HBs** al nacer. Sí a lactancia materna.

Meningitis (Profilaxis a Contactos)

TABLA 6.2.3: GERMEN VS PROFILAXIS	
GERMEN	PROFILAXIS
Haemophilus influenzae tipo b	Rifampicina 20 mg/kg/día × 4 días
Meningococo	Rifampicina × 2 días , o Ciprofloxacino 500 mg × 1 dosis (VO), o Ceftriaxona 250 mg IM × 1 (de elección en embarazadas)

Coqueluche (Tos Convulsa)

- Azitromicina × 5 días (profilaxis = tratamiento) a:

- **Contactos sintomáticos** (tos o cuadro catarral).
- Contactos de riesgo:
 - - Menores de 1 año (hospitalizarlos si < 3 meses)
 - - Menores de 2 años con esquema incompleto (< 3 dosis)
 - - Adultos mayores > 65 años
 - - Pacientes hospitalizados
 - - Embarazadas en 3er trimestre (preferir eritromicina)
 - - PortadorES de enfermedad pulmonar, cardíaca o epilepsia

Accidente Cortopunzante (Riesgo VIH)

TABLA 6.2.4: SEROLOGÍA DE LA FUENTE VS CONDUCTA	
SEROLOGÍA DE LA FUENTE	CONDUCTA
VIH (+) conocido	Triterapia antirretroviral × 6 semanas (obligatorio)
VIH desconocido	Ofrecer triterapia (recomendable, decisión del trabajador)
VIH (-) documentado	Observar solamente

Control con ELISA (o PCR/Ag p24) al día 0, 6 semanas y 3 meses. Siempre requiere **consentimiento informado** del paciente fuente para realizar la serología.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Médica de 30 años sufre accidente cortopunzante con aguja de paciente cuya serología VIH es desconocida. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Manejo de Contactos. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Contacto de TBC: pedir clínica, radiografía y baciloscopia a todos. PPD solo a menores de 15 años y VIH.
- Profilaxis TBC con isoniazida: PPD >10 mm = 6 meses; VIH con PPD >5 mm = 9 meses; menor de 15 años siempre (duración según PPD).
- Hepatitis A: extradomiciliarios se vacunan, intradomiciliarios reciben inmunoglobulina. Hepatitis B: exposición reciente = inmunoglobulina específica; alejada = vacuna.
- Meningitis: profilaxis solo para hemófilo (rifampicina 4 días) y meningococo (rifampicina 2 días, cipro o ceftriaxona dosis única). Embarazada: ceftriaxona.
- Coqueluche: azitromicina 5 días a sintomáticos y grupos de riesgo (menores de 1 año, >65 años, embarazo tercer trimestre, enfermedades descompensables).
- Accidente cortopunzante: fuente VIH+ o desconocida = triterapia profiláctica 6 semanas. ELISA control al inicio, 6 semanas y 3 meses.
- Lactancia materna NO contraindicada en TBC ni en hepatitis B. En TBC se usa mascarilla.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MANEJO DE CONTACTOS)**PREGUNTA 1**

Médica de 30 años sufre accidente cortopunzante con aguja de paciente cuya serología VIH es desconocida. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Esperar resultado del ELISA del paciente fuente antes de decidir
- B)** Ofrecer triterapia antirretroviral profiláctica por 6 semanas
- C)** Simplemente observar ya que la fuente probablemente es VIH negativa
- D)** Solicitar PCR para VIH al trabajador de salud de inmediato
- E)** Iniciar monoterapia con zidovudina por 4 semanas

PREGUNTA 2

Niño de 8 años, contacto intradomiciliario de padre con tuberculosis bacilífera. Baciloscopia negativa, radiografía normal, PPD 6 mm. ¿Cuál es la conducta?

- A)** Iniciar tratamiento antituberculoso completo con 4 fármacos
- B)** No requiere profilaxis ya que el PPD es negativo (<10 mm)
- C)** Isoniazida por 3 meses y controlar con nuevo PPD
- D)** Isoniazida por 6 meses sin control posterior
- E)** Vacunar con BCG y observar evolución

PREGUNTA 3

Embarazada de 32 semanas es contacto de compañero de trabajo diagnosticado con meningitis meningocócica. ¿Cuál es la profilaxis de elección?

- A)** Rifampicina por 2 días
- B)** Ciprofloxacino 500 mg dosis única vía oral
- C)** Ceftriaxona 500 mg intramuscular dosis única
- D)** Azitromicina por 5 días
- E)** No requiere profilaxis, solo observación

RESUMEN: MANEJO DE CONTACTOS

Esta clase revisa el manejo de contactos de las principales enfermedades infecciosas: tuberculosis, hepatitis A y B, meningitis, coqueluche y accidentes cortopunzantes. Los contactos se clasifican en intradomiciliarios (mismo techo) y extradomiciliarios (personas que pasan mucho tiempo juntas). Para tuberculosis, a todo contacto se le pide clínica, radiografía y baciloscopia. A menores de 15 años y VIH se agrega PPD. Se trata como caso si tiene baciloscopia positiva o si es menor de 15 con radiografía alterada. La profilaxis con isoniazida se indica según PPD (>10 mm por 6 meses, >5 mm en VIH por 9 meses). Todo menor de 15 recibe isoniazida siempre, con duración según PPD. El recién nacido de madre tuberculosa usa mascarilla, recibe isoniazida y la BCG se posterga. Para hepatitis A, contactos extradomiciliarios se vacunan, intradomiciliarios reciben inmunoglobulina específica o genérica. Para hepatitis B, exposición reciente (cortopunzante, sexual) recibe inmunoglobulina específica; contacto alejado se vacuna. Recién nacido de madre HBV recibe vacuna más inmunoglobulina. Para meningitis, solo hemófilo influenzae B (rifampicina 4 días) y meningococo (rifampicina 2 días, o ciprofloxacino/ceftriaxona 500 mg dosis única) requieren profilaxis. En embarazada contacto de meningococo, de elección es ceftriaxona. Para coqueluche, azitromicina 5 días a contactos sintomáticos y pacientes de riesgo (menores de 1 año, menores de 2 con esquema vacunal incompleto, mayores de 65, hospitalizados, embarazadas en tercer trimestre, enfermedades descompensables). En accidentes cortopunzantes, si la fuente es VIH positivo o desconocido, se ofrece triterapia antirretroviral profiláctica por 6 semanas, con ELISA de control al inicio, 6 semanas y 3 meses.